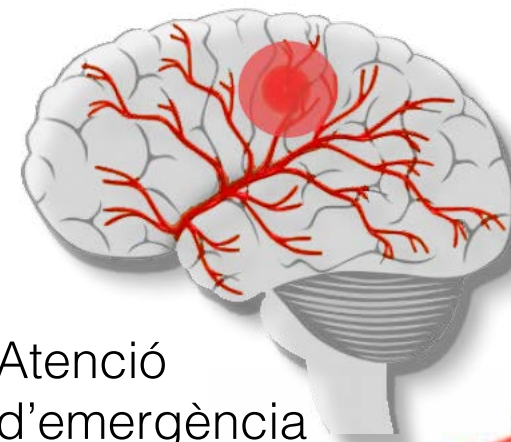


- **Agitació psicomotriu:** Valoreu Haloperidol 2.5-5 mg/i.v. Monitoratge ritme ECG. Compte efectes extrapiramidals. Eviteu benzodíacepins.
- **Arrítmies:** Es tractaran aquelles que provoquin inestabilitat hemodinàmica, segons guies d'actuació.
- **Coma (GCS<9):** Pacient inconscient, per preservar i garantir una via aèria permeable valoreu un aïllament de la via aèria mitjançant una intubació traqueal.
- **Crisi comicial:** Administreu benzodíacepins i.v. No de forma profilàctica.
- **Emergència hipertensiva:** TAS>220mmHg i/o TAD > de 120 mmHg Labetalol o Urapidil.
L'objectiu del tractament és disminuir la tensió arterial un 10% inicial. Eviteu hipotensors sublinguals.
Control de l'HTA: Ambient tranquil, tracteu el dolor, hipòxia. Revaloreu TA.
Només tractar per USVA medicalitzada si TAS > 220 i/o TAD >120 (eviteu reduccions >15%):
Labetalol i.v. 10 mg en 1-2 min, repetiu cada 10 min fins màxim de 150 mg o bomba de perfusió continuada (100 mg/80 SF de 2-10 ml/h).
En cas de contraindicació de B-bloquejants utilitzeu Urapidil. (10 mg en bolus lent i continueu amb perfusió de 4-8 mg/h en sèrum fisiològic).
- **Hipotensió arterial:** Descarteu situacions que requereixen un tractament específic i tracteu-les.
NO administreu sèrums hipotònics respecte al plasma (Sèrum glucosat, Ringer Lactat).
Valoreu l'administració de drogues vasoactives en situació de xoc.
- **Hipertensió intracraneal:** Situació crítica on la sospita diagnòstica és clínica i les opcions terapèutiques són molt limitades. Si sospiteu herniació:
Aplicueu els criteris de valoració inicial, A, B, C amb sedestació a 30° i Hipertònic. Valoreu individualment la necessitat d'aïllar la via aèria.
- **Hiperglucèmia (>180mg/dl):** L'objectiu és reduir fins uns 180 mg/dl en fase aguda. Cal evitar hipoglucèmies iatrogèniques. S'administrarà una dosi d'insulina ràpida en bolus i.v. segons glucèmia capil·lar:
<150mg/dl: 0 UI
150-250mg/dl: 4 UI
250-350mg/dl: 8 UI
>350mg/dl: 12 UI
- **Hipoglucèmia (<60 mg/dl):** La seva determinació és essencial en tot pacient agitat o amb focalitat neurològica, es corregirà amb l'administració de glucosa endovenosa (manteniu glucèmies > 70mg/dl).
- **Hipertèrmia:** S'ha relacionat amb empitjorament de l'àrea d'isquèmia.
Temperatura >37.5°C: paracetamol 1g i.v. Eviteu l'àcid acetilsalicílic.

CODI ICTUS



CODI ICTUS



Atenció d'emergència a la malaltia vascular cerebral



Autoria: Grup de Treball en ictus del SEM. Disseny: M. Fàbrega.

Salut/ emergències mèdiques

Generalitat de Catalunya

ESCALA RACE

Instruccions per aplicar l'escala RACE

Parèsia facial. Es puntua la simetria de la ganyota facial. Demaneu al pacient que somrigui o que ensenyi les dents.

Si el pacient no comprèn o no col·labora, es pot provocar una ganyota facial fent pressió amb els dits al darrera de les orelles.

Parèsia braquial o del braç. Es puntua el temps que els manté contra gravetat sense arribar a contactar amb la superfície sobre la que està recolzat.

Demaneu al pacient que aixequi els braços i que els mantingui alçats, a 45° si està estirat o a 90° si està assegut. Si el pacient no col·labora, col·loqueu els dos braços del pacient enlaire.

Parèsia crural o de la cama. Es puntua el temps que manté les cames contra gravetat sense arribar a contactar amb la superfície sobre la que està recolzat.

Demaneu al pacient que aixequi les cames i les mantingui alçades, a 30° amb el pacient estirat, flexionant els genolls si es necessari. Si el pacient no col·labora, col·loqueu les cames del pacient enlaire.

Desviació oculo-cefàlica

Valoreu si el pacient té tendència a girar el cap i dirigir la mirada cap a un costat. La direcció de la mirada és cap al costat contrari de la debilitat del cos.

Afàsia (en pacients amb debilitat al costat dret del cos)

Demaneu al pacient que faci dues ordres (sempre s'han de fer servir les mateixes ordres): 1) Tanqui els ulls / 2) Faci un puny amb la mà. Els pacients afàsics, amb comprensió alterada, no obeeixen les ordres.

Agnòsia (en pacients amb debilitat al costat esquerre del cos)

Valoreu si el pacient té asomatognòsia i anosognòsia.

1) Col·loqueu el braç o mà afectada (esquerra) davant de la cara del pacient i pregunteu-li "de qui és aquest braç/ mà?". Els pacients amb asomatognòsia no reconeixen el seu hemicòs esquerre.

2) Pregunteu al pacient si pot moure els dos braços i aplaudir. Els pacients amb anosognòsia no són conscients del déficit, contesten que sí i intenten aplaudir.

[Enllaç a video formatiu escala RACE](#)

[Enllaç a video formatiu escala RACE pediàtrica](#)

HEMICÒS ESQUERRE		HEMICÒS DRET	
Parèsia facial esquerra:		Parèsia facial dreta:	
Absent	0	Absent	0
Lleugera	1	Lleugera	1
Moderada / Severa	2	Moderada / Severa	2
Parèsia del braç esquerre:		Parèsia del braç dret:	
Absent/Lleugera (>10")	0	Absent/Lleugera (>10")	0
Moderada (<10")	1	Moderada (<10")	1
Severa (no l'aixeca)	2	Severa (no l'aixeca)	2
Parèsia de la cama esquerra:		Parèsia de la cama dreta:	
Absent/Lleugera (>5")	0	Absent/Lleugera (>5")	0
Moderada (<5")	1	Moderada (<5")	1
Severa (no l'aixeca)	2	Severa (no l'aixeca)	2
Desviació oculo-cefàlica a la dreta:		Desviació oculo-cefàlica a l'esquerra:	
Absent	0	Absent	0
Present	1	Present	1
Agnòsia:		Afàsia:	
Fa bé les 2 proves	0	Obeeix 2 ordres	0
Asomatognòsia o anosognòsia (Fa bé 1 prova)	1	Obeeix 1 ordre	1
Asomatognòsia i anosognòsia (Fa malament 2 proves)	2	No obeeix cap ordre	2
TOTAL		TOTAL	

Activeu sempre el CODI ICTUS, a través de CECOS, amb qualsevol puntuació de l'escala RACE

Puntuació: ≥ 5 Alta probabilitat d'oclusió arterial i ICTUS greu

TRANSMISSIÓ DE DADES A LA CENTRAL DE COORDINACIÓ

Registre SITREM

- Número CIP i Número DNI/NIF
- Hora inici símptomes (hora que va anar a dormir si és al despertar o últim cop que estava bé en cas de llevar-se al vespre)
- Presa o no d'Anticoagulants
- RAPID i RANCOM
- Escala clínica RACE (puntuació)
- Glicèmia capil·lar
- Pressió arterial
- Freqüència cardíaca
- Temperatura

ALGORITME GENÈRIC

